

Warszawa, 8 sierpnia 2024 r.

BEOS-WPMOSR-1693/24

Pan Minister
Dariusz Salamończyk
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

Ocena skutków regulacji

**zawartej w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw (druk 526) w wersji uwzględniającej autopoprawkę z dnia 18 lipca 2024 r.
(druk sejmowy nr 526-A)¹**

I. Jaki problem jest rozwiązywany?

Problemem, który ma być rozwiązany poprzez wprowadzenie proponowanych zmian, jest ustalenie na zbyt wysokim poziomie składki zdrowotnej, do której opłacania zobowiązane są ubezpieczeni. Zawarte w projekcie ustawy propozycje mają obniżyć wysokość składki opłacanej przez ubezpieczonych, zarówno pracowników, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Projekt przewiduje fundamentalne zmiany zasad ustalania i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obejmują one różne aspekty obliczania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Proponowane postulaty dotyczą formuły ustalania wysokości składki, określenia podstawy wymiaru składki oraz zasad opłacania składki w przypadku podlegania ubezpieczeniu z różnych tytułów lub osiągnięcia kilku przychodów z tego samego tytułu.

Istotną zmianą przewidzianą w projekcie jest kwestia opłacania składki zdrowotnej w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego. W obecnym stanie prawnym zasadą jest, że składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacać z każdego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Z kolei gdy w ramach jednego z tytułów dana osoba uzyskuje więcej niż jeden przychód, składkę zdrowotną trzeba

¹ Przedstawiciele wnioskodawców: poseł Mirosław Suchoń oraz poseł Ryszard Petru.

odprowadzać odrębnie od każdego przychodu. Projekt zakłada, że w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu lub w ramach jednego z tytułów uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka będzie opłacana od jednego z tytułów lub przychodów wybranego przez ubezpieczonego. W projekcie nie wskazano, że ma być to tytuł, z którego ubezpieczony uzyskuje najwyższe przychody. Zmiana ta w bardzo korzystny sposób wpłynie na obciążenia składkowe osób posiadających kilka źródeł przychodów. Jest to zmiana o charakterze fundamentalnym dla systemu finansowania ubezpieczeń zdrowotnych, która w istotny sposób wpłynie na wysokość przychodów ze składki zdrowotnej.

Dnia 18 lipca 2024 r. do Sejmu wpłynęła autopoprawka do projektu, która zawiera zmiany w zakresie sposobu ustalania wysokości składki zdrowotnej oraz zasad jej opłacania w stosunku do propozycji zawartych w pierwotnym projekcie.

W autopoprawce zaproponowano wprowadzenie nowych zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. W pierwotnym projekcie ustalono wysokość składki w sposób ryczałtowy (przewidziano trzy ryczałtowe kwoty w wysokości 300 zł, 525 zł i 700 zł miesięcznie, zależnie od przychodu, wynagrodzenia, uposażenia lub świadczeń w roku kalendarzowym). Autopoprawka przewiduje wprowadzenie ryczałtowego określenia wysokości składki jako procentu podstawy wymiaru, za którą przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zaproponowano trzy ryczałtowe wysokości składki: 4% 7% i 9%. Wysokość składki w konkretnym miesiącu uzależniona będzie od kwoty wszystkich oskładkowane przychodów ubezpieczonego od początku roku kalendarzowego do 85.000 zł, powyżej 85.000 zł do 300.000 zł oraz powyżej 300.000 zł. Na dzień wniesienia projektu autopoprawki kwoty te wyniosłyby odpowiednio po zaokrągleniu: 300 zł 525 zł i 700 zł. W związku ze zmianą sposobu ustalania wysokości składki zdrowotnej z kwotowej na procentową od wskazanej podstawy zrezygnowano z przewidzianej w pierwotnym projekcie regulacji wprowadzającej zasadę waloryzacji składki, ponieważ zmiana jej wysokości będzie wynikać ze wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Projekt autopoprawki przewiduje że w przypadku gdy w trakcie roku kalendarzowego łączna kwota przychodów przekroczy 85.000 zł. albo 300.000 zł

składka będzie opłacana w wysokości określonej dla danego przedziału za wszystkie miesiące od początku roku kalendarzowego. Powyższe oznacza, że ubezpieczony będzie zobowiązany do dokonania dopłaty składki za miesiące, w których składka była opłacana w niższej wysokości.

W przypadku, gdy w danym miesiącu kwota przychodu, dochodu, wynagrodzenia, uposażenia lub świadczenia jest niższa od kwoty obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, wysokość składki wynosić ma 9% tego przychodu, dochodu, wynagrodzenia, uposażenia lub świadczenia, nie więcej jednak niż najniższa składka wprowadzona nowelizacją.

II. Rekomendowane rozwiązanie (w tym planowane narzędzia interwencji) i oczekiwany efekt

W projekcie przewidziano istotną zmianę zasad ustalania i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne zarówno w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji, jak i propozycji zawartych w pierwotnym projekcie. Proponowane postulaty dotyczą formuły ustalania wysokości składki – odejście od zaproponowanej w projekcie metody kwotowej do ustalania wysokości składki jako procentu wskazanej podstawy wymiaru. Przyjęta formuła dla większości ubezpieczonych ma charakter korzystny w porównaniu do obecnych rozwiązań, ponieważ spowoduje zmniejszenie ich obciążeń finansowych oraz uproszczenie ustalania wysokości składki. Zaproponowane zmiany mają charakter systemowy w zakresie konstrukcji formuły wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wejście ich w życie w bardzo istotny sposób wpłynęłoby na poziom finansowania ubezpieczenia zdrowotnego.

W pierwotnym projekcie ustawy zaproponowano sztywną formułę określania wysokości składki zdrowotnej w postaci ustalonych kwot, w tym najniższej kwoty. Ta zaproponowana minimalna kwota ryczałtowa (300 zł) dla niektórych osób, w szczególności uzyskujących niskie przychody byłaby wyższa niż obecnie przez nich płacona składka zdrowotna (stanowi ona bowiem procent przychodu). W autopoprawce zaproponowano regulację, przewidującą że, gdy w danym miesiącu kwota przychodu dochodu wynagrodzenia uposażenia lub świadczenia jest niższa od kwoty obowiązującego minimalnego wynagrodzenia wysokość składki wynosi 9% tego przychodu, dochodu, wynagrodzenia, uposażenia lub świadczenia nie więcej jednak niż najniższa składka wprowadzona nowelizacją. Powyższe oznacza, że zmieniono

niekorzystne rozwiązanie dla tej grupy ubezpieczonych przewidziane w pierwotnym projekcie.

W pierwotnym projekcie ustawy nie przewidziano rozliczenia rocznego składki zdrowotnej. Powyższe oznaczało że ubezpieczeni, którzy przekroczą progi przychodowe, z którymi wiąże się obowiązek zapłaty składki w wyższej wysokości, w trakcie roku kalendarzowego będą opłacali podwyższoną składkę dopiero po przekroczeniu danego progu. W konsekwencji osoby, które powinny znaleźć się w drugiej lub trzeciej grupie ze względu na wysokość osiąganych przychodów, przez pewną część roku opłacałyby składki w wysokości niższej niż wynikałoby to z osiąganych przez nich realnych skumulowanych przychodów. W projekcie autopoprawki wprowadzono regulację przewidującą, że w przypadku przekroczenia progów przychodowych składka za wszystkie miesiące do początku roku kalendarzowego jest płacona w wyższej wysokości i zastosowana będzie dopłata. Przyjęte rozwiązanie doprowadzi do zwiększenia obciążenia składką zdrowotną osób uzyskujących wyższe przychody i uniemożliwi opłacanie niższych składek ze względu na datę uzyskania wyższych przychodów.

Projekt był przedmiotem:

- opinii w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 526) w wersji uwzględniającej autopoprawkę z dnia 18 lipca 2024 r. (przedstawiciele wnioskodawców: poseł Mirosław Suchoń oraz poseł Ryszard Petru) (BEOS-WPEiM-1691/24);
- opinii w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 526) w wersji uwzględniającej autopoprawkę z dnia 18 lipca 2024 r. (przedstawiciele wnioskodawców: poseł Mirosław Suchoń oraz poseł Ryszard Petru) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu (BEOS-WPEiM-1692/24).

III. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich UE/OECD?

Rozwiązania legislacyjne w zakresie źródeł finansowania publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwach UE i OECD opierają się głównie na dwóch modelach.

Część publicznych systemów opieki zdrowotnej jest finansowana przede wszystkim ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa lub budżetów samorządowych (np.: w Danii, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii). W innych państwach głównym źródłem finansowania publicznego systemu opieki zdrowotnej są składki na ubezpieczenie zdrowotne (np.: w Czechach, Estonii, Holandii, Niemczech, Słowenii)².

W Czechach składka na obowiązkowe ubezpieczanie zdrowotne dla pracowników wynosi 13,5% wynagrodzenia brutto (4,5% od pracownika i 9% od pracodawcy). Osoby samozatrudnione opłacają składkę zdrowotną w wysokości 13,5% podstawy, którą stanowi 50% rocznego przychodu po odliczeniu poniesionych kosztów. Minimalna wysokość składki dla osoby samozatrudnionej w 2024 r. wynosi 2 968 CZK (117,5 EUR³) miesięcznie. Ponadto osoby samozatrudnione uzyskujące roczne przychody w wysokości do 2 000 000 CZK (79 180 EUR) mogą płacić zryczałtowany podatek, który obejmuje składkę zdrowotną, w kwocie uzależnionej od wysokości i rodzaju przychodu⁴.

W Estonii składka na ubezpieczanie zdrowotne stanowi część składki społecznej i dla pracowników obliczana jest proporcjonalnie do przychodu. W 2024 r. wysokość składki zdrowotnej wynosi 13% przychodów. Minimalna miesięczna podstawa wyliczenia składki społecznej (w tym zdrowotnej) wynosi 725 EUR. Osoby samozatrudnione opłacają składkę zdrowotną w tej samej wysokości tj. 13% przychodu⁵.

W Holandii każda osoba pracująca w tym kraju musi opłacać w ramach powszechnego systemu (*zorgverzekerings*) składkę zdrowotną, na którą składa się stawka nominalna w wysokości ok. 1 768 EUR oraz składka odprowadzana przez pracodawcę w wysokości 6,57% przychodu (maksymalny przychód stanowiący

² *Health at a Glance 2023, OECD Indicators*, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/7a7afb35-en/index.html?itemId=/content/publication/7a7afb35-en>.

³ Według referencyjnego kursu Europejskiego Banku Centralnego z 19.07.2024 r.

⁴ *PwC Worldwide Tax Summaries, Czech Republic*, <https://taxsummaries.pwc.com/czech-republic/individual/other-taxes>; informacje ze strony Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowotnych (*Všeobecná zdravotní pojišťovna*), <https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/platby-zdravotniho-pojisteni-v-roce-2024>; <https://www.vzp.cz/platci/informace/osvc/vymerovaci-zaklad-a-vypocet-pojistneho/jaky-je-minimalni-vymerovaci-zaklad>; Baza MISSOC: <https://www.missoc.org/missoc-database/>.

⁵ *PwC Worldwide Tax Summaries, Estonia*, <https://taxsummaries.pwc.com/estonia/individual/other-taxes>; informacje ze strony internetowej estońskiej administracji skarbowej: <https://www.emta.ee/en/business-client/taxes-and-payment/income-and-social-taxes/social-tax>.

podstawę wymiaru składek to 71 628 EUR rocznie). W przypadku osób samozatrudnionych wysokość składki wynosi w 2024 r. 5,32%⁶.

W Niemczech ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym (*Gesetzliche Krankenversicherung*, GKV) objęci są pracownicy, których wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia przekracza 538 EUR miesięcznie, ale nie przekracza rocznego limitu zarobków (*Jahresarbeitsentgeltgrenze*), który w 2024 r. wynosi 69 300 EUR⁷. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 14,6% przychodu (7,3% od pracodawcy i 7,3% od pracownika). Maksymalna roczna podstawa wymiaru składek w 2024 r. wynosi 62 100 EUR. Osoby samozatrudnione mogą ubezpieczyć się w ramach ustawowego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli ubezpieczone są w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, opłacają składkę w wysokości 14,6% przychodu, a maksymalna roczna podstawa wymiaru składek w 2024 r. wynosi 62 100 EUR (5 175 EUR miesięcznie). Minimalna miesięczna podstawa wymiaru składki wynosi 1 178,33 EUR⁸.

W Słowenii składka na ubezpieczanie zdrowotne dla pracowników obliczana jest proporcjonalnie do przychodu i w 2024 r. wynosi 6,36% przychodu od pracownika i 6,56% przychodu od pracodawcy. Dla osób samozatrudnionych składka wynosi 13,45% podstawy, uzależnionej od wysokości dochodu za poprzedni rok pomniejszonego o 25%. Minimalna i maksymalna wysokość składki ustalana jest w odniesieniu do średniego wynagrodzenia. Dla minimalnej składki podstawę stanowi 60% średniego wynagrodzenia w Słowenii za rok poprzedni i w 2024 r. minimalna składka wynosi 214,23 EUR. Dla maksymalnej składki podstawę stanowi trzypółkrotność średniego wynagrodzenia i w 2024 r. wynosi ona 1 080,51 EUR. Dodatkowo od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono obowiązkową ryczałtową składkę zdrowotną, która jest opłacana za okres od stycznia 2024 r. dla wszystkich ubezpieczonych, którzy opłacają inne obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie od stycznia 2024 r. do lutego 2025 r. wynosi ona 35 EUR

⁶ Informacje ze strony internetowej holenderskiej administracji podatkowej:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/zorgverzekeringwet/veranderingen-bijdrage-zvw/#; *PwC Worldwide Tax Summaries, Netherlands*, <https://taxsummaries.pwc.com/netherlands/individual/other-taxes>.

⁷ Próg ten wynosi 62 100 EUR dla osób, które były ubezpieczone prywatnie od 31 grudnia 2002 r.

⁸ Informacje ze strony internetowej Federalnego Ministerstwa Zdrowia, <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/online-ratgeber-krankenversicherung/krankenversicherung.html>; *PwC Worldwide Tax Summaries, Germany*, <https://taxsummaries.pwc.com/germany/individual/other-taxes>.

miesięcznie. Wysokość składki będzie korygowana raz w roku, 1 marca, o wzrost średnich zarobków brutto w roku poprzednim. Osoby prowadzące działalność gospodarczą są również zobowiązane do opłacania ryczałtowej składki zdrowotnej⁹.

IV. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Projektowana regulacja będzie miała wpływ m.in. na:

- przedsiębiorców, samozatrudnionych oraz osoby wykonujące pracę najemną (łącznie ok. 16 mln osób) – po jej wprowadzeniu od 1 stycznia 2025 r. w przypadku większości podmiotów nastąpiłoby zmniejszenie obciążeń związanych z płaconymi składkami zdrowotnymi;
- emerytów i rencistów (łącznie ok. 9,4 mln osób¹⁰) – przyjęcie proponowanych w autopoprawce rozwiązań spowoduje zmniejszenie lub utrzymanie doczasowego poziomu obciążeń składką zdrowotną;
- Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – zmniejszenie wpływów z tytułu składki zdrowotnej musiałyby zostać zrekompensowane zwiększoną dotacją z budżetu państwa;
- budżet państwa – wystąpiłaby konieczność zasilania dotacyjnego NFZ celem pokrycia zmniejszonych wpływów z tytułu składki zdrowotnej.

V. Informacje o zakresie, czasie trwania i wynikach konsultacji

Zgodnie z informacjami z Systemu Informacyjnego Sejmu, w dniu 28 czerwca 2024 r. Marszałek Sejmu skierował projekt do konsultacji (SN, PG, NRA, KRRP, RDS, RMiŚP, KIG, RNZUS, ZUS i Lewiatan).

Sąd Najwyższy do projektu ustawy przedstawił *Opinię w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 lipca 2024 r.*¹¹ (nr BSA

⁹ The OECD Tax-Benefit Database. Description of policy rules for Slovenia 2022, December 2022, <https://www.oecd.org/social/benefits-and-wages/TaxBEN-Slovenia-2022.pdf>; OECD Tax Database Explanatory Annex Part III Social Security Contributions, May 2023, <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database/social-security-contributions-explanatory-annex.pdf>; Informacje ze strony internetowej słoweńskiego rządu: <https://www.gov.si/novice/2023-12-29-z-novim-letom-prihaja-obvezni-zdravstveni-prispevek/>.

¹⁰ W tym 8,4 mln osób otrzymujących emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych oraz blisko 1 mln osób otrzymujących emerytury i renty z systemu rolniczego (stan na koniec kwietnia 2024 r.), zob. <https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych>.

¹¹ <https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/druk.xsp?nr=526>.

II. 021.51.2024). W opinii wskazano, że „w kontekście równego traktowania jednostek (ubezpieczonych) wątpliwości budzi, czy poprawne konstytucyjnie jest różnicowanie mechanizmu ustalania wysokości składek zdrowotnych”. Wskazano na brak uzasadnienia przyjętych w projekcie rozwiązań i odwołano się do art. 68 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie równego dostępu do świadczeń z opieki zdrowotnej. Sformułowano również uwagi dotyczące mechanizmu zapłaty składki przy zróżnicowanych progach dochodowych. Przy czym należy zaznaczyć, że mechanizm określający sposób zapłaty składki przy przychodach przekraczających określony w ustawie próg został inaczej ukształtowany w autopoprawce złożonej do przedmiotowego projektu.

VI. Wpływ na sektor finansów publicznych

Proponowana regulacja będzie wywoływała istotne skutki dla budżetu państwa. Wystąpi bowiem konieczność wyasygnowania dotacji, której wysokość pokryłaby ubytek wpływów do NFZ z tytułu składki zdrowotnej. Jej wysokość wnioskodawcy oszacowali w autopoprawce na poziomie ok. 25-30 mld zł, tj. o 10-15 mld zł wyższej niż w pierwotnym projekcie ustawy (ok. 15 mld zł). W uzasadnieniu do projektu ustawy (druk sejmowy nr 526) wnioskodawcy wskazali również na możliwe źródła finansowania projektowanej regulacji¹²

- ok. 8 mld zł poprzez redukcję części wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz innych funduszy celowych, a także ich konsolidację,
- ok. 5 mld zł dzięki poprawie efektywności zamówień publicznych,
- ok. 3 mld zł w wyniku lepszego planowania, nadzoru oraz kontroli kosztów w inwestycjach infrastrukturalnych,
- ok. 3 mld zł dzięki poprawie działania administracji podatkowej,
- ok. 3 mld zł w wyniku redukcji zatrudnienia w administracji publicznej o 10%,
- ok. 2,2 mld zł poprzez sprzedaż niewykorzystywanych nieruchomości Skarbu Państwa oraz zredukowanie kosztów zarządzania i ich utrzymywania,

¹² Uzasadnienie do projektowanej regulacji, s. 16-17.

- ok. 0,55 mld zł w wyniku restrukturyzacji lub likwidacji instytutów państwowych¹³.

Łączne zaproponowane źródła finansowania wynoszą ok. 24,75 mld zł, tak więc teoretycznie jest to kwota zbliżona do planowanego deficytu związanego z analizowanym projektem. Warto jednak nadmienić, iż wg wstępnego projektu planu finansowego NFZ na 2025 r. wpływy z tytułu składki zdrowotnej mają wynieść ponad 173 mld zł (wzrost o prawie 20 mld zł w porównaniu do 2024 r.), a łączne zaplanowane koszty świadczeń medycznych mają przekroczyć 183,6 mld zł¹⁴. Jeśli przyjąć zaprezentowane w uzasadnieniu projektu wpływy ze składki zdrowotnej na 2025 r. za prawidłowo oszacowane (144 mld zł)¹⁵, to po uwzględnieniu dalszego zmniejszenia wpływów ze składek wynikającego z rozwiązań zaproponowanych w autopoprawce – przy planowanych przez NFZ na 2025 r. wpływach ze składek na poziomie ponad 173 mld zł – deficyt może być znacznie większy i wynieść od ok. 39 mld zł¹⁶ do nawet 44 mld zł¹⁷, a wskazane w uzasadnieniu źródła finansowania będą niewystarczające do jego pełnego pokrycia. Alternatywą pozostaje zwiększenie o brakującą kwotę deficytu budżetu państwa w 2025 r. i w kolejnych latach, co należy ocenić negatywnie biorąc pod uwagę ogólną sytuację finansową państwa.

Na problem dużej deficytowości systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce zwracają uwagę także niektórzy eksperci, którzy lukę finansową NFZ na lata 2025-2027 w scenariuszu zakładającym utrzymanie sprawności funkcjonowania na obecnym poziomie (tzw. scenariusz bazowy) oszacowali na poziomie 129,5 mld zł¹⁸. W toku dalszych prac nad projektowaną regulacją zasadne jest zatem pozyskanie od

¹³ Należy zwrócić uwagę, że poszukując źródeł finansowania projektowanej ustawy wnioskodawcy nie objęli analogicznymi rozwiązaniami w zakresie składki zdrowotnej jakie zaproponowano w projekcie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Ich składka wynosi zaledwie 1 zł za każdy przeliczeniowy hektar powierzchni za każdego ubezpieczonego rolnika oraz jego domownika, zob. art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146).

¹⁴ Strona internetowa NFZ: <https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pieniadze-na-zdrowie-w-2025-r-nfz-przygotowal-projekt-planu-finansowego,8634.html>. [dostęp: 26 lipca 2024 r.]

¹⁵ W uzasadnieniu brak jest danych, jak oszacowano tę kwotę. Jeśli przyjąć, że została ona prawidłowo oszacowana, to z uzasadnienia dołączonego do autopoprawki można wywnioskować, że zostanie ona jeszcze zmniejszona o dalsze 10-15 mld zł.

¹⁶ 144 mld zł minus 173 mld zł minus 10 mld zł.

¹⁷ 144 mld zł minus 173 mld zł minus 15 mld zł.

¹⁸ S. Dudek, Ł. Kozłowski, B. Waśko, W. Wiśniewski, *Luka finansowa systemu ochrony zdrowia – perspektywa 2025–2027*, s. 5.

Ministerstwa Finansów szczegółowych informacji na temat skutków finansowych projektowanej regulacji dla budżetu państwa.

Proponowana regulacja nie będzie wiązała się z bezpośrednimi skutkami finansowymi dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Warto jednak odnotować, iż niższe składki zdrowotne powinny przełożyć się na wzrost popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego, a tym samym na zwiększenie wpływów podatkowych z podatków PIT i CIT (dochody z nich zasilają również budżety JST), jak również VAT (wyłączny dochód budżet państwa).

VII. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Proponowane w projekcie rozwiązania powinny wpłynąć korzystnie na konkurencyjność polskiej gospodarki i rozwój przedsiębiorczości. Będą się one bowiem wiązały się ze zmniejszeniem obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne płaconych zarówno przez przedsiębiorców, jak i pracowników, co z kolei wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe przedsiębiorstw i wywoła wzrost łącznego popytu na towary i usługi, i w rezultacie przełoży się na produkt krajowy brutto.

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. regulacje prawne (Polski Ład) wprowadziły szereg zmian w opodatkowaniu dochodów. Zlikwidowano m.in. możliwości odliczania od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotyczy to zarówno podatników będących przedsiębiorcami, jak również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wprowadzono następujące regulacje dotyczące składki zdrowotnej¹⁹:

- 1) przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (podatek dochodowy obliczany według skali – odpowiednio 12% do 120 tys. zł i 32% po przekroczeniu tego progu dochodowego) – płacą miesięczną składkę zdrowotną wynoszącą 9% osiągniętych dochodów, ale podstawa obliczenia składki nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 lutego 2024 r. minimalna wysokość składki wynosi 381,78 zł²⁰);

¹⁹ Rozdział 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146).

²⁰ Od lutego 2024 r. do stycznia 2025 roku wysokość składki wynosi: 9% x 4 242 zł = 381,78 zł.

- 2) przedsiębiorcy, których dochody opodatkowane są podatkiem liniowym (jednolita stawka PIT wynosząca 19%) – płacą miesięczną składkę zdrowotną wynoszącą 4,9% osiągniętych dochodów, ale podstawa obliczenia składki nie może być niższa niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia (od 1 lutego 2024 r. minimalna wysokość ich składki wynosi, podobnie jak w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, 381,78 zł); jednocześnie ta grupa przedsiębiorców ma możliwość zaliczenia składek zdrowotnych zapłaconych za siebie oraz osoby współpracujące do kosztów uzyskania przychodów lub odliczenia od dochodu, przy czym łączna wartość składek zaliczonych do kosztów lub odliczonych od dochodu w 2024 r. nie może przekroczyć kwoty 11 600 zł²¹;
- 3) przedsiębiorcy, którzy od osiągniętych przychodów opłacają zryczałtowany podatek dochodowy (różne stawki PIT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej) – płacą miesięczną składkę zdrowotną wynoszącą 9% podstawy wymiaru składki zdrowotnej, którą ustala się jako odpowiedni procent kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, w zależności od wysokości przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne²², osiągniętego od początku roku kalendarzowego²³. Formułę obliczania składki zdrowotnej dla tej grupy podatników zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Podstawa wymiaru oraz wysokość składki zdrowotnej dla podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od 1 lutego 2024 r.

²¹ Zasady rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców w 2024 r., Przewodnik dla podatnika, Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa, s. 2, https://www.podatki.gov.pl/media/9767/_poradnik_zasady_rozliczania_skladki_na_ubezpieczenie_zdrowotne_przez_przedsiębiorcow.pdf. [dostęp: 26 lipca 2024 r.]

²² Dz. U. z 2022 r. poz. 2540, ze zm.

²³ Przychód ten przedsiębiorca pomniejsza o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, ale pod warunkiem, że nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przychodach tych nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych <https://www.pit.pl/zus-przedsiębiorcow-poradnik/skladka-zdrowotna-przedsiębiorcow-w-2024-r-1009366>. [dostęp: 26 lipca 2024 r.]

Wysokość przychodu	Miesięczna podstawa wymiaru		Kwota składki (9% podstawy)
	formuła obliczania	kwota podstawy wymiaru	
do 60 000 zł	60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia	4 660,71 zł	419,46 zł
od 60 001 zł do 300 000 zł	100% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia	7 767,85 zł	699,11 zł
powyżej 300 000 zł	180% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia	13 982,13 zł	1 258,39 zł

Źródło: Strona internetowa Pit.pl: <https://www.pit.pl/zus-przedsiębiorców-poradnik/składka-zdrowotna-przedsiębiorców-w-2024-r-1009366>. [dostęp: 26 lipca 2024 r.]

Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą pomniejszyć przychody z tej działalności o 50% zapłaconych za siebie i osoby współpracujące składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- 4) przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność, którzy opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej – płacą miesięczną składkę zdrowotną od podstawy, którą jest minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku. W ich przypadku podstawa wymiaru składki od 1 lutego 2024 r. wynosi 4 242 zł, a kwota składki wynosząca 9% podstawy jest równa 381,78 zł. W przypadku tej grupy podatników możliwe jest obniżenie podatku ustalonego w decyzji naczelnika urzędu skarbowego o kwotę wynoszącą 19% zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Propozycje przedstawione w autopoprawce zakładają wprowadzenie zróżnicowanej składki zdrowotnej w wysokości 4%, 7% albo 9,4% podstawy wymiaru. Wysokość składki będzie zależała od wysokości łącznej kwoty przychodu, dochodu, wynagrodzenia, uposażenia lub świadczeń w roku kalendarzowym²⁴. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie stanowiła kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale roku poprzedniego²⁵. Bazując na dostępnych danych GUS dotyczących kwoty tego wynagrodzenia

²⁴ Zgodnie z obowiązującym art. 79 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka wynosi co do zasady 9% podstawy wymiaru, czyli dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne.

²⁵ Włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

w III kwartale 2023 r. (7 465,32 zł²⁶) można oszacować kwoty składek zdrowotnych, które płaciliby ubezpieczeni w zależności od wysokości swoich przychodów, dochodów, wynagrodzeń, uposażeń lub świadczeń w roku kalendarzowym. Jeśli ich roczna wysokość będzie wynosiła:

- od 0 do 85 000 zł – wówczas składka zdrowotna wyniesie od 0 do 298,62 zł miesięcznie²⁷,
- powyżej 85 000 zł do 300 000 zł – kwota składki będzie równa 522,57 zł miesięcznie²⁸,
- powyżej 300 000 zł – składka zdrowotna wyniesie 701,74 zł miesięcznie²⁹.

Ustawa miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., tak więc kwota przeciętnego wynagrodzenia, która byłaby podstawą obliczenia składki ulegnie zwiększeniu, a w konsekwencji kwoty składki również byłyby wyższe. Warto również odnotować, iż jeśli w trakcie roku kwota przychodów, dochodów, wynagrodzeń, uposażeń lub świadczeń w roku kalendarzowym przekroczy próg 85 000 zł lub 300 000 zł wówczas składkę w podwyższonej wysokości trzeba będzie odprowadzić za wszystkie miesiące od początku roku kalendarzowego. Następowałoby to jednorazowo w miesiącu, w którym nastąpiłoby przekroczenie progu, od którego zależałaby wysokość składki.

Wydaje się, że zaproponowane w autopoprawce rozwiązania sprawiają, że dla zdecydowanej większości ubezpieczonych zmiany będą korzystne lub neutralne. Dla przedsiębiorców i samozatrudnionych osiągających najniższe przychody zmiany będą korzystne, gdyż obecnie płacą oni składkę w wysokości co najmniej 381,78 zł miesięcznie, a po zmianach składka zmniejszyłaby się do poziomu ok. 300 zł miesięcznie. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku pracowników najemnych oraz osób świadczących pracę w oparciu o inne rodzaje umów. Przykładowo pracownik na etacie zarabiający minimalne wynagrodzenie (wynoszące od 1 lipca

²⁶ Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2023 r. zob. <https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiębiorstw-włącznie-z-wypłatami-z-zysku-w-trzecim-kwartale-2023-roku,58,40.html> [dostęp: 26 lipca 2024 r.]

²⁷ $0,04 \times 7\,465,32 \text{ zł} = 298,62 \text{ zł}$.

²⁸ $0,07 \times 7\,465,32 \text{ zł}$.

²⁹ $0,094 \times 7\,465,32 \text{ zł}$.

2024 r. 4 300 zł) zamiast obecnych 333,94 zł składki zdrowotnej zapłaciłby ok. 300 zł miesięcznie, tj. o 10,2% mniej. Dla osoby zarabiającej 10 000 zł brutto składka zdrowotna wyniosłaby ok. 523 zł miesięcznie, tj. byłaby o 32,7% niższa niż obecnie (776,61 zł). Na duże oszczędności mogliby również liczyć przedsiębiorcy oraz pracownicy najemni osiągający bardzo wysokie przychody (dochody). Obecnie bowiem w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych lub wg jednolitej 19% stawki podatkowej nie obowiązuje żaden górny limit wysokości przychodów (dochodów), po przekroczeniu którego dana osoba przestaje płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany zaproponowane w autopoprawce powinny sprawić, że nowelizowane przepisy nie powinny spowodować wzrostu obciążeń składką zdrowotną osób o najniższych dochodach np. rencistów, emerytów czy osób zatrudnionych na część etatu. Zgodnie bowiem z proponowanym przepisem, gdy w danym miesiącu kwota przychodu, dochodu, wynagrodzenia, uposażenia lub świadczenia będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, wysokość składki zdrowotnej będzie wynosiła 9% tego przychodu, dochodu, wynagrodzenia, uposażenia lub świadczenia nie więcej niż 4% podstawy, tj. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w trzecim kwartale poprzedniego roku.

Oceniając skutki społeczne projektu, należy zwrócić uwagę na fakt, iż wywoła on spadek wpływów do NFZ z tytułu składki zdrowotnej, a źródłem finansowania projektowanych rozwiązań ma być szereg tytułów zaproponowanych w uzasadnieniu. Nie stanowią one treści samego projektu, a jedynie kierunkowo wskazują na potencjalne oszczędności, dzięki którym w budżecie państwa znalazłyby się dodatkowe środki o charakterze dotacyjnym dla NFZ. Jeśli ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2025 r., to należy oczekiwać, iż również zmiany prawne i organizacyjne pozwalające na wygenerowanie tych oszczędności musiałyby wejść w życie w tym samym czasie. W przeciwnym wypadku, przy braku wystarczających środków na finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce na dotychczasowym poziomie, należy oczekiwać pogorszenia dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, co wywoływałoby negatywne skutki w wymiarze społecznym, gospodarczym, zdrowotnym i politycznym.

Projektowana ustawa może mieć niewielki negatywny wpływ na poziom stopy inflacji w związku z wydatkowaniem przez przedsiębiorców i osoby fizyczne dodatkowych środków „zaoszczędzonych” na niższej składce zdrowotnej.

VIII. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

Projekt nie przewiduje wprowadzenia nowych obciążeń regulacyjnych lub obowiązków informacyjnych.

IX. Wpływ na rynek pracy

Przyjęcie projektu, którego skutkiem byłoby obniżenie wysokości składki zdrowotnej, a tym samym zmniejszenie całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika może wywoływać następujące skutki dla rynku pracy:

- niższe składki zdrowotne to wyższe wynagrodzenia netto, a tym samym rosłaby atrakcyjność polskiego rynku pracy zarówno dla Polaków, jak również pracowników z zagranicy,
- przyjęcie zbliżonych zasad oskładkowania przedsiębiorców i pracowników najemnych zmniejszyłoby bodźce do zwiększania fikcyjnego samozatrudnienia.

X. Wpływ na pozostałe obszary

Projektowana ustawa może wpłynąć pozytywnie na zwiększenie niskiej stopy oszczędności Polaków ³⁰. Trudno jednak prognozować, jaki odsetek „zaoszczędzonych” przez podatników składek na ubezpieczenie zdrowotne zostałby wydatkowany na bieżąco, a w jakim stopniu środki te byłyby przeznaczone na odroczoną konsumpcję.

XI. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

³⁰ Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce jest jedną z najniższych wśród państw członkowskich UE, choć wykazuje tendencję wzrostową zob. <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teina500/default/table> [dostęp: 26 lipca 2024 r.]

XII. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Projektodawcy nie wskazują sposobu ani terminu ewaluacji.

Autorzy:

dr hab. Magdalena Szczepańska (pkt I, II, V, VIII, XI, XII)
ekspert ds. legislacji
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

dr Piotr Russel (pkt IV, VI, VII, IX, X)
specjalista ds. systemu gospodarczego
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

dr Danuta Adamiec (pkt III)
specjalista ds. systemu gospodarczego
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Akceptował:
Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Piotr Chybalski

Piotr Chybalski